طبع فى 21/10/2026 15:28:57

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : مريم عيد شاكر ابراهيم

المحافظة : بني سويف **الحي / المدينة :** بني سويف **العنوان :** بنى بخيت -مركز بنى سويف-بنى سويف

رقم البطاقة : 27806182200847 **رقم التليفون :** 01222513196 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 18-06-1978 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------) **التوقيع:**(--------------------------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني	**الوظيفة :** ---------------------------	**التوقيع:** د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن	**الوظيفة :** ---------------------------	**التوقيع:** ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان	**الوظيفة :** ---------------------------	**التوقيع:** نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

G R I - E
جوستاف روسي
جوستاف روسي مصر

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------ **ا.د/** ------------------------ **د/** ------------------------ **د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --

خطة العلاج : --

المستشفي : -- **قسم :** --

جهة العلاج : -- **نفقات :** --

ملاحظات : --

رئيس **المجلس الطبي المتخصص**	**مدير عام** **مديرية الشئون الصحية**	**ختم** **شعار الجمهورية**

Name: مريم عيد شاكر ابراهيم
National ID: 27806182200847

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

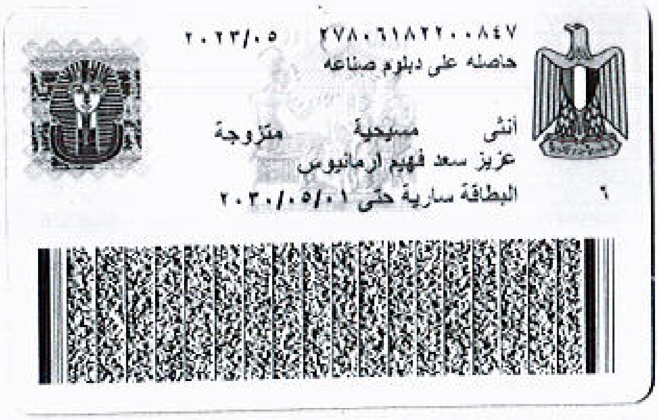
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	الوقت : **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٧٨٠٦١٨٢٢٠٠٨٤٧ ٢٠٢٣/٠٥

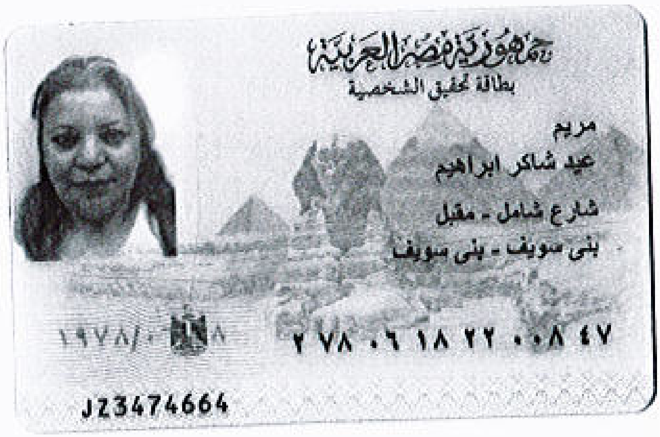
حاصله على دبلوم صناعه

أنثى مسيحية متزوجة

عزيز سعد فهيم ارمانيوس

٦ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٥/٠١

Dms



جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية

مريم

عيد شاكر ابراهيم

شارع شامل - مقبل

بنى سويف - بنى سويف

٢ ٧٨ ٠٦ ١٨ ٢٢ ٠٠٨ ٤٧ ١٩٧٨/٠ ٨

J23474664

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

3 / 9 / 2025 G

Name	منصور محمد عجيبه	MRN	1999/2025
		ID	27609232401148
Age	48	Phone	01211229234
Menopausal status	Premenopausal	Marital status	
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	
CO morbidity			

Clinical Data

BX: 2.0 cm grade II

ER: 0/8	PR: 0/8	HER 2: 3+	Ki67: 20%

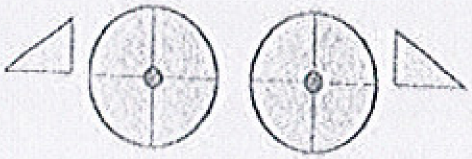
Sonomammography:

cT4b N2

Mets Workup:

(Met liver) hydr plasic
CT

R L



TNM
4N2①

Recommendations:

Triphasic CT showed progressing hepatic focal lesion (Now 2.0x1.9cm)

MDT OUTCOME & PLAN

[Taxol weekly + Herceptin I.V]

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: مريم عيد شاكر

MR. : 435

GUSTAVE ROUSSY

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من

بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :

تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is receiving FASLODEX and IBRANCE 125 mg, with ZOLADEX scheduled for 25 August 2026, as noted in the pharmacy record.

The patient is taking FASLODEX and IBRANCE 125 mg; laboratory results are within normal limits. A bone scan is scheduled for June 2026, and the results are pending.

The patient continues FASLODEX and IBRANCE 125 mg; laboratory values remain acceptable. ZOLADEX is planned for 25 August 2026, as recorded in the pharmacy.

تحريرا في ,

التاريخ : **20-09-2026**

الوقت :

الطبيب المعالج : اسماء محمد مصطفي نصر

يعتمد ,

GUSTAVE / ROUSSY

Patient Name	: [illegible]	Request No	: 13003692
Patient No	: 27609232401148	Request Date	: 30/06/2025
Path No.	: SR-897/25	Verification Date	: 02/07/2025
Sex	: Female	Financial Category	: وزارة [illegible] - فئة الدولة
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass.

Nature of Specimen: Slides revision (Tru-cut biopsy).

Gross Examination:
- One referred block labelled as (124-25). Together with five referred slides including 1 H&E stained slide and 4 immunostained slides for (ER, PR, HER2 & KI67).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2)
* DCIS: Not detected.
* Angioinvasion: Not detected.
* Perineural invasion: Not detected.
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity)
- ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8)
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67: 70%.

Diagnosis:
Right breast mass, Slides revision (Tru-cut biopsy):
- Invasive duct carcinoma, Grade 2
IHC
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: 70%

Verified by :
Dr Duaa Mohamed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name : [illegible]
Patient No : 27609232401148
Path No. : SR-897/25
Sex : Female
Age : 48 Y
Referring Doc :

Request No : 13003692
Request Date : 30/06/2025
Verification Date : 02/07/2025
Financial Category : [illegible]
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

* Scoring system: 'ER, PR'

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: 'Her2'

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations 2013 IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within ≤ 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within ≤ 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim,
Dr. Heba Hassan Adly.

Verified by
[illegible] Mohamed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m818

ر المريض	منصورة محمد عتبه مصطفى	النوع	Female
ـسن	48 Y	العنوان	القاهره
يخ اخذ العينة		تاريخ استلام العينة	22/06/2025 15:03
ب التحليل	مركز صحه المرأة	تاريخ التقرير	24/06/2025 08:36
ية	مركز صحه المرأة		

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER &PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX / ULTRA .
Sample recived was treated by :- CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbeit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: NO nuclear staining of tumour cells
PR: NO nuclear staining of tumour cells
HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.
Ki67 :positive nuclear staining of about 20 % of tumour cells

Referal Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: NEGATIVE
PR: NEGATIVE
HER2NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 20 % .
(CORE BIOPSY)

Pathologist [illegible]

Lab Director: [illegible]

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient ID: 84294	Patient Name English: Mansourah Mohamed Alabah
[illegible] Age:	2025/06/19 10:17:59 AM Report Date

summary: 48-year-old, right breast palpable lump from few month

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Dense fibro glandular parenchyma, (ACR c) which may obscuring small lesion
- At upper quadrants shows distortions , asymmetrical densities and mild skin thickening
- Ultrasound demonstrated a corresponding shows ill defined heterogenous area seen between 9-2 o'clock with mild overlying skin thickening .
- At 12 o'clock zone c shows hypoechoic solid mass with irregular and angular margin as well as internal vascular signal depicted by color Doppler study, about 12cm from the nipple and 14mm from the skin, it measuring 26x17mm
- Prominent retroareolar duct measuring 2mm in caliber with clear pattern
- Enlarged more than three pathological axillary node ,largest one measures 14x12 mm at level I

Left breast

- Dense fibro glandular densities (ACR density c). which may obscuring small lesion
- No asymmetric densities, distortion or suspicious micro calcifications.
- Ultrasound shows mottling parenchymal appearance with scattered few cyst largest 6mm ,no solid lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 5): malignant looking solid mass and non mass lesion for CESM and biopsy

left breast (BIRADS 2): adenosis with cyst formations

Recommendations: Biopsy was done on the same sitting from right breast

Dr. Marwa M.Hassan

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]